



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN PENGORGANISASIAN
UNIT INTENSIVE**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 826.17/I-PDM/DIR/IX/2025

TENTANG

PEDOMAN PENGORGANISASIAN *INTENSIVE CARE UNIT*

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin kualitas pelayanan dan keselamatan yang efektif dan efisien bagi pasien *Intensive Care Unit* (ICU) di rumah sakit
- b. Bahwa dengan ditetapkannya pedoman pelayanan *Intensive Care Unit* (ICU) di rumah sakit dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1778/Menkes/SK/XII/2010 perlu disusun petunjuk teknis sebagai acuan pelaksanaan, pengembangan dan evaluasi pelayanan *Intensive Care Unit* (ICU) di rumah sakit
- Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruh a dan b perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang petunjuk teknis penyelenggaraan *Intensive Care Unit* (ICU) di rumah sakit
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di Fasyankes;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Fasyankes;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
9. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1042.92/DPMI-KEP/DIR/IX/2025 tentang Pengangkatan PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang;
10. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN PENGORGANISASIAN *INTENSIVE CARE UNIT*

Pasal 1

Pedoman Pengorganisasian *Intensive Care Unit* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Pengorganisasian *Intensive Care Unit* digunakan sebagai acuan dalam Organisasi Unit Laboratorium di Rumah Sakit Prima Husada.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 140.A/RSPH/I-PER/DIR/VI/2015 tentang Pedoman Pengorganisasian *Intensive Care Unit* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 08 September 2025

PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 826.17/I-PDM/DIR/IX/2025
TENTANG
PEDOMAN PENGORGANISASIAN ICU

BAB I
PENDAHULUAN

Rumah sakit sebagai salah satu subsistem pelayanan kesehatan memberikan dua jenis pelayanan kepada masyarakat yaitu pelayanan kesehatan dan pelayanan administrasi. Pelayanan kesehatan mencakup pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, rehabilitasi medik dan pelayanan perawatan. Pelayanan tersebut dilaksanakan melalui unit gawat darurat, unit rawat jalan, dan unit rawat inap.

Dalam perkembangannya pelayanan rumah sakit tidak terlepas dari pembangunan ekonomi masyarakat. Perkembangan ini tercermin pada perubahan fungsi klasik RS yang pada awalnya hanya memberi pelayanan yang bersifat penyembuhan (kuratif) terhadap pasien. Karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan pendapatan dan pendidikan masyarakat, rumah sakit pun semakin meningkatkan pelayanannya. Pelayanan rumah sakit saat ini tidak hanya bersifat kuratif (penyembuhan) tetapi juga bersifat rehabilitatif (pemulihan) yang dilaksanakan secara terpadu melalui upaya promosi kesehatan (promotif) dan pencegahan (preventif).

Pedoman organisasi rumah sakit menyatakan bahwa rumah sakit harus melaksanakan beberapa fungsi, satu diantaranya adalah fungsi menyelenggarakan pelayanan penunjang medik dan nonmedik. Dalam hal penunjang medik, salah satu pelayanan yang penting adalah pelayanan intensive care unit. Instalasi intensive care unit di rumah sakit merupakan satu-satunya unit di rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan ICU yang berkualitas dan mengedepankan keselamatan pasien di Rumah Sakit

BAB II

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

2.1. DESKRIPSI RS PRIMA HUSADA

Rumah Sakit Prima Husada berlokasi di Banjararum Selatan Mondoroko, Kec. Singosari, Kab. Malang 65153, Jawa Timur, Indonesia. Telp. 0341 – 458679, 458916, Fax: 0341 – 441874, email primahusadamalang@gmail.com/ info@rs-primahusada.com, website rs-primahusada.com.

Rumah Sakit Prima Husada adalah salah satu Rumah Sakit yang memberikan pelayanan langsung khususnya pelayanan kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur dan memiliki 3 Manajer yaitu Manajer Pelayanan dan Manajer Keuangan dan Akuntansi dan Manajer Umum dan di dalam tugasnya dibantu oleh Kepala Bidang dan Kepala Bagian.

Rumah Sakit Prima Husada dengan pelayanan meliputi pelayanan Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Kamar Operasi, Penunjang Medik, dan Penunjang Non Medik, serta Instalasi Rawat Inap yang terdiri dari kelas I, II, III, VIP dan VVIP.

Dalam upaya memberikan pelayanannya, rumah sakit dituntut memberikan pelayanan sebaik – baiknya sebagai *public service*. Meningkatnya tuntutan dapat dilihat dengan munculnya kritik – kritik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan yang diberikan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Rumah Sakit Prima Husada perlu menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan secara bertahap melalui upaya program peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.

2.2. SEJARAH INSTITUSI RS PRIMA HUSADA

Berawal dari Praktek pribadi dr. Sadi Hariono, MMRS sebagai dokter umum sejak tahun 1990 di Banjararum Selatan No. 3B, kami telah mengabdikan diri melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Seiring dengan perkembangan penduduk dan peningkatan kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang lebih luas, maka kami pun berupaya mengembangkan diri untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap, sehingga mengantarkan kami pada berdirinya Rumah Sakit Prima Husada.

Perjalanan Peningkatan Status Pelayanan :

Tahun 1990 – 2005	:	Praktek Pribadi Dokter Umum
Tahun 2005 – 2009	:	Balai Pengobatan Prima Husada
Agustus 2009	:	Klinik Rawat Inap Layanan Medik Dasar
Mei 2010	:	Menjadi Rumah Sakit Umum dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang
Tahun 2010 – 2014	:	Izin Operasional Rumah Sakit Sementara
Februari 2015	:	Izin Operasional Rumah Sakit Tetap
Februari 2016	:	Penetapan Rumah Sakit Tipe C
Maret 2016	:	Akreditasi Paripurna
Desember 2016	:	Penghargaan Rumah Sakit Trauma Center terbaik se Malang Raya 2016
April 2017	:	Juara 1 Pelayanan dan Respon terbaik (Dinkes Kab. Malang)

Desember 2017	:	Penghargaan Rumah Sakit Trauma Center terbaik se Jawa Timur
Februari 2018	:	Pengembangan Gedung DPM Menjadi tempat dokter internsip

BAB III

VISI, MISI, FALSAFAH, NILAI, DAN TUJUAN RS

3.1. VISI

Rumah Sakit Prima Husada memiliki visi :

“ Menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat.”

3.2. MISI

Rumah Sakit Prima Husada memiliki misi :

1. Memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat, dan akurat.
2. Mengutamakan kepuasan pasien.
3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan.

3.3. FALSAFAH

Memberikan pelayanan secara professional berlandaskan hati nurani yang berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien.

3.4. LANDASAN 7 NILAI BUDI UTAMA

Rumah Sakit Prima Husada memiliki Landasan 7 Nilai Budi Utama :

1. Jujur
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

3.5. TUJUAN

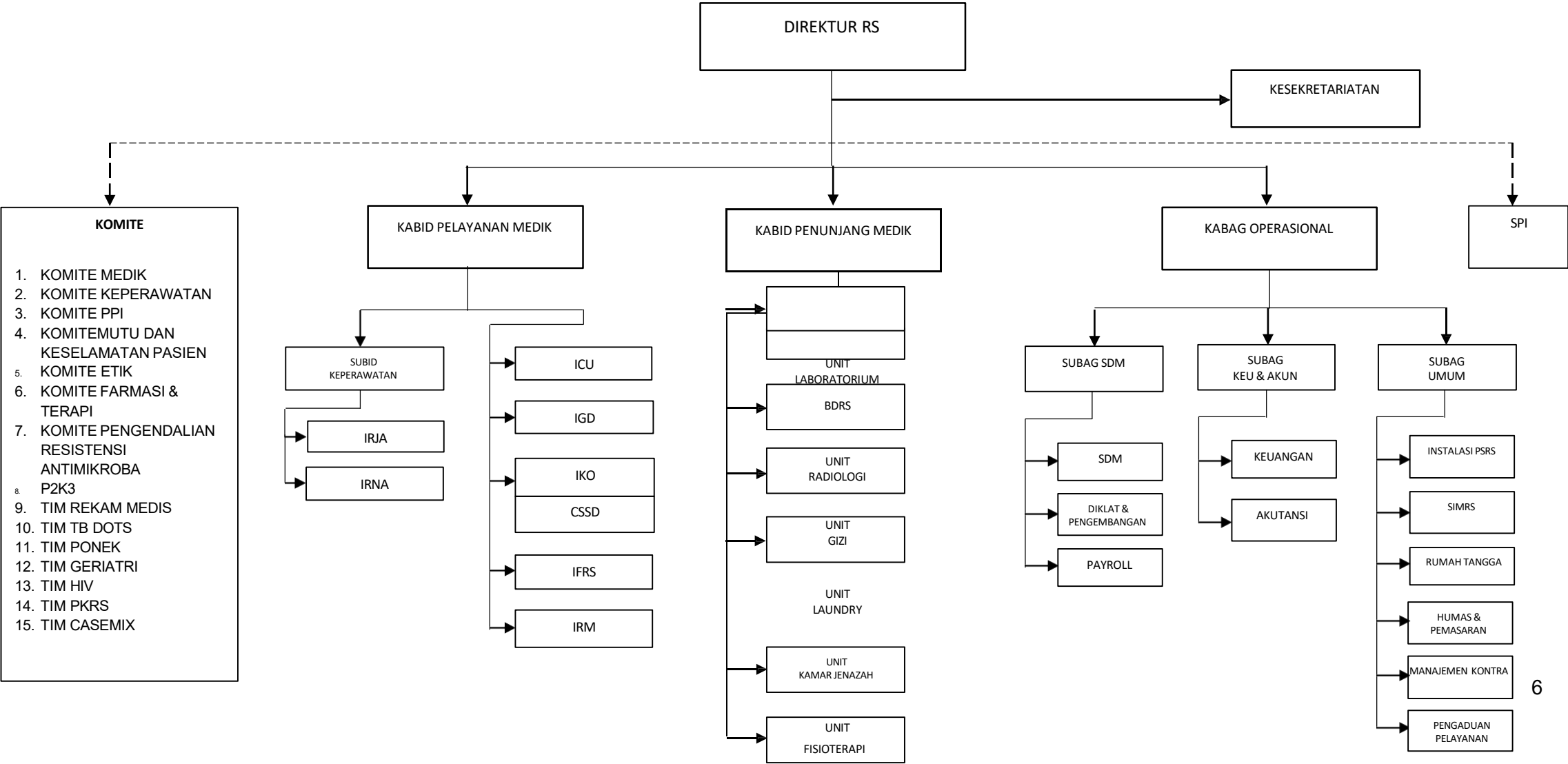
Rumah Sakit Prima Husada menjadi Rumah Sakit yang memberikan solusi kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Malang dan sekitarnya.

3.6. MOTTO

“Sahabat Menuju Sehat”

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI RS. PRIMA HUSADA

4.1. BAGAN ORGANISASI



4.2. KETERANGAN / PENGERTIAN

1. Unit Struktural

a. Direktur Rumah Sakit

Adalah kepala atau pejabat tertinggi di RS Prima Husada.

b. Kepala Bidang / Kepala Bagian

Adalah pejabat yang membantu Direktur dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan bidang masing-masing yaitu :

1) Kepala Bidang Pelayanan Medik membantu Direktur dalam bidang Pelayanan Rumah Sakit.

2) Kepala Bidang Penunjang Medik membantu Direktur dalam bidang Penunjang Rumah Sakit.

3) Kepala Bidang Operasional membantu Direktur dalam bagian :

- SDM yang meliputi ketenagakerjaan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia .

- Keuangan dan Akutansi meliputi keuangan, akutansi dan pajak rumah sakit.

- Umum meliputi : Saranan dan Prasarana Rumah Sakit, SIMRS, Rumah Tnagga, Humas dan Pemasaran, Manajemen Kontrak, dan Pengaduan Pelayanan serta hubungan dengan pihak eksternal.

c. Kepala Sub Bidang

Adalah pejabat yang membatu Kepala Bidang Pelayanan Medik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang masing-masing yaitu :

1) Sub Bidang Keperawatan membantu Kepala Bidang Pelayanan Medik dalam bidang Keperawatan.

d. Kepala Sub Bagian

Adalah pejabat yang membatu Kepala Bagian Operasional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang masing – masing yaitu :

1) Sub Bagian SDM membantu Kepala Bagian Operasional dalam melaksanakan tugas terkait ketenagakerjaan Rumah Sakit

2) Sub Bagian Keuangan dan Akutansi membantu Kepala Bagian Operasional dalam melaksanakan tugas terkait Keuangan dan Akutansi.

3) Sub Bagian Umum membantu Kepala Bagian Operasional dalam melaksanakan tugas terkait Sarana Prasaran Rumah Sakit, SIMRS, Security, Cleaning Service, Humas dan Pemasaran, Manajemen KONtrak dan Pengaduan Pelayanan

e. Kepala Instalasi dan Kepala Unit

Adalah suatu wadah struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dan memiliki fungsi tertentu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rumah sakit baik berfungsi pelayanan maupun pendukung operasional rumah sakit.

Berikut adalah daftar kepala instalasi dan kepala bagian :

1) Kepala Instalasi Rawat Jalan

2) Kepala Instalasi Rawat Inap

3) Kepala *Intensive Care Unit*

4) Kepala Instalasi Gawat Darurat

5) Kepala Instalasi Kamar Operasi

6) Kepala Instalasi Farmasi

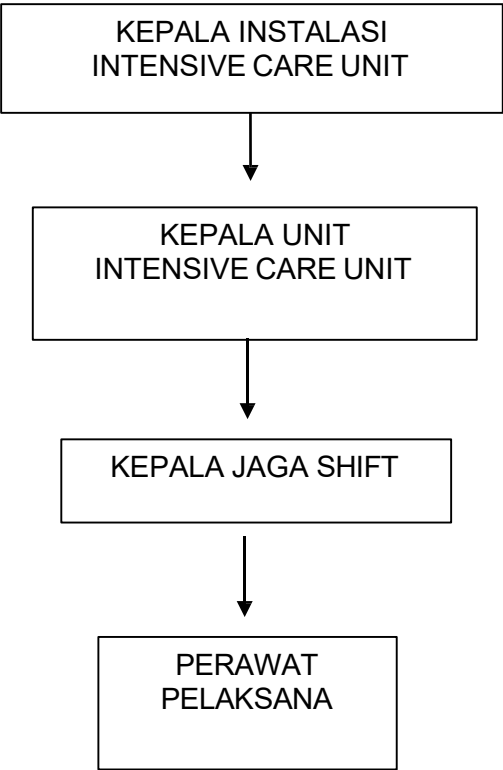
-
- 7) Kepala Instalasi Rekam Medis
 - 8) Kepala Unit Laboratorium
 - 9) Kepala Unit Radiologi
 - 10) Kepala Unit Gizi
 - 11) Kepala Unit Laundry
 - 12) Kepala Unit Kamar Jenazah
 - 13) Kepala Unit Fisioterapi
 - 14) Kepala Bagian SDM
 - 15) Kepala Bagian Keuangan dan Akutansi
 - 16) Kepala Bagian Umum

2. Unit Non Struktural

Adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli dan profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit. Komite/ Panitia / Tim yang ada di Rumah Sakit Prima Husada adalah sebagai berikut:

- a. Komite Medik
- b. Komite Keperawatan
- c. Komite PPI
- d. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien
- e. Komite Etik
- f. Komite Farmasi & Terapi
- g. Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba
- h. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)
- i. Tim Rekam Medis
- j. Tim TB DOTS
- k. Tim PONEK
- l. Tim Geriatri
- m. Tim HIV
- n. Tim PKRS
- o. Tim Casemix

BAB V
STRUKTUR ORGANISASI *INTENSIVE CARE UNIT*



BAB VI
URAIAN JABATAN

6.1. URAIAN JABATAN

No	Nama Jabatan	Persyaratan Jabatan
1.	Kepala Instalasi ICU	1. Pendidikan a. Dokter Spesialis Anestesi b. Spesialis anestesiologi dan pelatihan ACLS, BLS 2. Pengalaman Kerja a. Dokter spesialis anestesi fungsional di Rumah Sakit lebih dari tiga tahun 3. Keterampilan a. Memiliki keterampilan dalam perencanaan, penggerak dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi 4. Usia a. Tidak ditentukan
		5. Uraian Tugas a. Menyusun dan melaksanakan perencanaan program dana anggaran Instalasi Intensive care unit terkait SDM, Fasilitas, Pengembangan Pelayanan, Mutu, Keselamatan Pasien, dan Keselamatan Kerja Instalasi Intensive care unit. b. Menyusun dan melaksanakan program orientasi untuk pelaksana. c. Menyusun dan melaksanakan program peningkatan mutu dan Keselamatan Pasien di Intensive care unit. d. Berkoordinasi dengan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien dalam menyusun rancang ulang program peningkatan mutu di Instalasi Intensive care unit dan melaksanakannya. e. Menyusun perencanaan dan memastikan keberadaan dan pembaharuan perijinan bagi staf, fasilitas, dan hal-hal terkait di unitnya. f. Merencanakan dan melaksanakan kerjasama dengan unit atau instansi lain sesuai kebutuhan unit. g. Menyusun rencana kerja sesuai tujuandan target pelayanan yang ditetapkan oleh rumahsakit.

		6. Tanggung Jawab a. Bertanggungjawab Kepada Direktur Rumah Sakit Prima Husada. b. Membantu dalam menyusun rencana kerja sesuai tujuandan target pelayanan yang ditetapkan oleh rumahsakit. c. Menetapkan pembagian pekerjaan, batasan tugas, tanggungjawab, serta wewenang dan hubungan kerja yang jelas.
--	--	---

		7. Wewenang a. Meneliti, menganalisa dan mengevaluasi data yang masuk b. Menyusun prioritas usulan kebutuhan Instalasi Care Unit sebagai masukan guna penyusunan anggaran c. Membimbing dan memberi pengarahan kepada bawahan d. Memberi saran untuk bahan pertimbangan atasan e. Menandatangani dokumen-dokumen terkait pelayanan ICU f. Menyampaikan usulan kepada atasan
No	Nama Jabatan	Persyaratan Jabatan
2.	Kepala Ruang ICU	1. Pendidikan a. S1 Keperawatan 2. Sertifikasi a. Surat Sumpah Profesi b. STR c. SIK d. Pelatihan ICU Pemula e. Pelatihan ICU Dasar 3. Pengalaman kerja a. Minimal 3 tahun dibidangnya 4. Keterampilan a. Memiliki keterampilan dalam perencanaan, penggerak dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi 5. Usia a. 25 tahun – 50 tahun

		6. Uraian Tugas a. Membantu menyusun dan melaksanakan perencanaan program dan anggaran Instalasi ICU terkait SDM, Fasilitas, Pengembangan Pelayanan, Mutu, Keselamatan Pasien, dan Keselamatan Kerja Instalasi ICU. b. Membantu menyusun dan melaksanakan program orientasi untuk pelaksana. c. Membantu menyusun dan melaksanakan program peningkatan mutu dan Keselamatan Pasien di Instalasi ICU. d. Membantu dalam berkoordinasi dengan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien dalam menyusun rancang ulang program peningkatan mutu di Instalasi ICU dan melaksanakannya. e. Membantu menjaga agar proses penyusunan dan pelaksanaan setiap kegiatan di Instalasi ICU disesuaikan dan/atau berdasarkan peraturan perundangan dan hukum yang berlaku f. Membantu menyusun perencanaan dan memastikan keberadaan dan
--	--	--

		pembaharuan perijinan bagi staf, fasilitas, dan hal-hal terkait di unitnya g. Membantu merencanakan dan melaksanakan kerjasama dengan unit atau instansi lain sesuai kebutuhan unit. h. Menyusun rencana kerja sesuai tujuandan target pelayanan yang ditetapkan oleh rumah sakit. i. Melakukan koordinasi sebagai upaya peningkatan kinerjadan mutu pelayanan j. Pengembangan tatalaksana kerja, tugas-tugas,dan tanggungjawab. k. Melakukan pembagian tugas di lingkup internalinstalasi. l. Bekerjasama dengan bagian terkait yang diberikan kepadapasien. m. Membimbing dan melakukan fungsi pengawasanterhadap pelaksana. n. Menyiapkan sarana, prasarana, fasilitas, dan lingkungan kerjayang sesuai untuk kelancaran pelayanan dan memudahkan pasien dalam menerima pelayanan. o. Memastikan pelayana pasien sesuai standar prosedur operasional yang berlaku. p. Memelihara peralatan medis agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai. q. Melakukan sosialisasi mengenai peraturan/tata tertib yang berlaku di rumah sakit serta fasilitas yang ada dan cara penggunaanya. r. Menjaga fasilitas yang ada, melakukan sosialisasi cara penggunaan, pemeliharaan, dan evaluasi terkait umur pemakaian fasilitas yang ada di unitnya. s. Menciptakan hubungan kerjasama yang baik dengan sesama karyawan maupun pasien dan keluarganya. t. Mengkaji kebutuhan dan masalah kesehatan pasien sesuai dengan kompetensinya. u. Menciptakan dan memelihara lingkungan yang bersih dan suasana yang baik antar pasien dan keluarganya sehingga tercipta ketenangan. v. Mengikuti pertemuan yang diperlukan baik rutin maupun non rutin. w. Membimbing dan melakukan fungsi
--	--	--

		pengawasan terhadap tenaga perawat pelaksana. x. Melakukan evaluasi kinerja, sumber daya manusia dalam lingkup kerjanya. y. Berperan serta dalam membahas kasus sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan.
--	--	---

		z. Melakukan pengawasan kerja pelaksana di lapangan dengan berdasar pada pedoman pelayanan, panduan, standar prosedur operasional dan ketentuan – ketentuan lain yang telah ditetapkan.
		7. Tanggung Jawab a. Bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi ICU. b. Bertanggung jawab atas pelayanan dan ketenagaan keseharian di Instalasi ICU.
		8. Wewenang a. Membantu Kepala Instalasi untuk melakukan tugas rutin di instalasi ICU rumah sakit. b. Melakukan koordinasi sebagai upaya peningkatan kinerja dan mutupelayanan. c. Pengembangan tatalaksana kerja, tugas-tugas,dan tanggungjawab. d. Melakukan pembagian tugas di lingkup internal instalasi ICU. e. Membantu melaksanakan program orientasi untuk karyawan ICU. f. Melakukan evaluasi kinerja,sumber daya manusia dalam lingkup kerjanya. g. Menyiapkan sarana, prasarana, fasilitas, dan lingkungan kerja yang sesuai untuk kelancaran pelayanan dan memudahkan pasien dalam menerima pelayanan. h. Melakukan sosialisasi mengenai peraturan/tata tertib yang berlaku di rumah sakit serta fasilitas yang ada dancara penggunaanya. i. Menciptakan hubungan kerjasama yang baik dengan sesama karyawan maupun pasien dan keluarganya. j. Menciptakan dan memelihara hubungan kerja yangbaik dengan instalasi/bagian lain yang terkait. k. Berperan serta dalam membahas kasus sebagai upaya untuk meningkatkan mutu. l. Pemantauan penempelan label untuk obat yang memiliki kewaspadaan tinggi.
No	Nama Jabatan	Persyaratan Jabatan

3.	Kepala Shift	1. Pendidikan a. S1 Keperawatan b. D3 Keperawatan 2. Sertifikasi a. Surat Sumpah Profesi b. STR c. SIK d. Pelatihan ICU Pemula e. Pelatihan ICU Dasar 3. Pengalaman kerja a. Minimal 2 tahun dibidangnya 4. Keterampilan a. Memiliki keterampilan dalam
----	--------------	---

		perencanaan, penggerak dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi 5. Usia a. 23 tahun – 45 tahun
		6. Uraian Jabatan a. Mengikuti pelatihan dan seminar b. Membimbing siswa / mahasiswa PKL c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan d. Menyiapkan fasilitas dan lingkungan di Instalasi ICU untuk kelancaran pelayanan e. Melakukan pertolongan pertama kepada pasien dalam keadaan gawat darurat secara tepat dan cepat f. Memberikan asuhan keperawatan yang telah dilakukan g. Menerima pasien baru sesuai dan ketentuan yang berlaku serta melaksanakan orientasi kepada Pasien dan mengirim penderita ke Instalasi lain h. Menciptakan dan memelihara hubungan kerja yang baik dengan anggota tim i. Melakukan absensi setiap akan melakukan tugas j. Melakukan tugas jaga sore, malam, hari libur secara bergiliran sesuai jadwal dinas k. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan asuhan keperawatan yang tepat dan benar l. Melaksanakan serah terima tugas kepada petugas pengganti secara lisan maupun tertulis administrasinya m. Memberikan penyuluhan kesehatan kepada Pasien dan Keluarganya n. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik antara Pasien, Keluarga serta Perawat dengan Perawat dan Perawat dengan Dokter o. Memesan Diet Pasien p. Melaksanakan tindakan delegasi medis (Infus, Oksigenasi, dll)
		7. Tanggung Jawab a. Secara administrasi fungsional bertanggung jawab kepada kepala ruang. b. Bertugas melaksanakan asuhan keperawatan kepada penderita di Unitnya

		8. Wewenang a. Memberi masukan kepada Kepala Ruang b. Sebagai koordinasi pelaksana kegiatan perawatan di bawah tanggung jawabnya
--	--	---

No	Nama Jabatan	Persyaratan Jabatan
4.	Perawat Pelaksana	1. Pendidikan a. S1 Keperawatan b. D3 Keperawatan 2. Sertifikasi a. Surat Sumpah Profesi b. STR c. SIK d. Pelatihan ICU Pemula e. Pelatihan ICU Dasar 3. Pengalaman kerja a. Minimal 1 tahun dibidangnya 4. Keterampilan a. Memiliki keterampilan dalam perencanaan, penggerak dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi 5. Usia a. 23 tahun – 40 tahun

		6. Uraian Tugas a. Mengikuti pelatihan dan seminar b. Membimbing siswa / mahasiswa PKL c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan d. Menyiapkan fasilitas dan lingkungan di Instalasi Anestesiologi dan Reanimasi untuk kelancaran pelayanan e. Melakukan pertolongan pertama kepada pasien dalam keadaan gawat darurat secara tepat dan cepat f. Memberikan asuhan keperawatan yang telah dilakukan g. Menerima pasien baru sesuai dan ketentuan yang berlaku serta melaksanakan orientasi kepada Pasien dan mengirim penderita ke Instalasi lain h. Menciptakan dan memelihara hubungan kerja yang baik dengan anggota tim i. Melakukan absensi setiap akan melakukan tugas j. Melakukan tugas jaga sore, malam, hari libur secara bergiliran sesuai jadwal dinas k. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan asuhan keperawatan yang tepat dan benar l. Melaksanakan serah terima tugas kepada petugas pengganti secara lisan maupun tertulis administrasinya m. Memberikan penyuluhan kesehatan kepada Pasien dan Keluarganya n. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik antara Pasien, Keluarga serta Perawat dengan Perawat dan Perawat dengan Dokter o. Memesan Diet Pasien p. Melaksanakan tindakan delegasi medis (Infus, Oksigenasi, dll)
--	--	--

		7. Tanggung Jawab a. Secara administrasi fungsional bertanggung jawab kepada kepala jaga b. Bertugas melaksanakan asuhan keperawatan kepada penderita di Unitnya
		8. Wewenang a. Memberi masukan kepada Kepala jaga b. Sebagai koordinasi pelaksana kegiatan perawatan di bawah tanggung jawabnya

6.2. TUGAS KLINIS

Tugas klinis yang dimaksud adalah seseorang yang bekerja di bidang manajemen mempunyai uraian tugas jabatan dan uraian tugas fungsional dan dilengkapi oleh SPK dan RKK.

a. Kepala Instalasi

No	Kompetensi
1.	Fungsi Penggerakan dan Pelaksanaan - Melakukan koordinasi sebagai upaya peningkatan kinerja dan mutu pelayanan. - Pengembangan tatalaksana kerja, tugas-tugas, dan tanggung jawab. - Menetapkan pembagian pekerjaan, batas tugas, tanggung jawab, serta wewenang dan hubungan kerja yang jelas - Bekerjasama dengan bagian terkait yang lain. - Membimbing dan melakukan fungsi pengawasan terhadap Kepala Ruangan dan pelaksana. - Menyiapkan sarana, prasarana, fasilitas, dan lingkungan kerja yang sesuai untuk kelancaran pelayanan dan memudahkan pasien dalam menerima pelayanan. - Memastikan pelayanan pasien sesuai Pedoman Praktik Klinik dan standar prosedur operasional yang berlaku. - Memelihara peralatan medis agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai. - Melakukan sosialisasi mengenai peraturan / tata tertib yang berlaku di rumah sakit dan menjaga agar seluruh sumber daya manusia di unitnya selalu patuh terhadap peraturan di rumah sakit. - Menjaga fasilitas yang ada, melakukan sosialisasi cara penggunaan, pemeliharaan, dan evaluasi terkait umur pemakaian fasilitas yang ada di unitnya. - Menciptakan hubungan kerjasama yang baik dengan sesama karyawan maupun pasien dan keluarganya. - Menciptakan dan memelihara lingkungan yang bersih dan suasana yang baik antar pasien dan keluarganya sehingga tercipta ketenangan. - Mengikuti pertemuan berkala yang diadakan secara rutin. - Menjaga proses kontrol mutu terhadap ikatan kerja sama yang ada - Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang laboratorium, antara lain melalui pertemuan ilmiah dan pelatihan. - Memastikan bahwa semua hasil yang dikeluarkan oleh laboratorium telah tervalidasi dengan baik dan benar.

	q. Memastikan bahwa semua hasil nilai kritis laboratorium telah terlapor dengan baik.
2.	Fungsi Pengawasan dan Evaluasi a. Melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi kinerja sumber daya manusia, fasilitas, dan pengembangan pelayanan dalam lingkup kerjanya. b. Melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap program dan anggaran yang telah dibuat. c. Melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi dan rancang ulang program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di unitnya. d. Melakukan evaluasi terhadap perijinan bagi diri sendiri, staf di bawahnya, fasilitas yang ada dan hal-hal terkait, sesuai peraturan perundangan dan hukum yang berlaku. e. Melakukan evaluasi terhadap mutu dari proses kerja sama dengan unit dan instansi lain.

b. Perawat Klinik I

Perawat klinis I adalah jenjang perawat klinis dengan kemampuan melakukan asuhan keperawatan dasar dengan penekanan pada keterampilan teknis keperawatan dibawah bimbingan. Kompetensi perawat klinis I yaitu:

No	Kompetensi
1.	Melakukan asuhan keperawatan (pengkajian,menetapkan diagnosis keperawatan,menetapkan intervensi dan melaksanakan tindakan keperawatan serta evaluasi) dengan lingkup keterampilan tehnik dasar.
2.	Menerapkan prinsip etik, legal, dan pekabudaya dalam asuhan keperawatan.
3.	Melakukan komunikasi terapeutik di dalamasuhan keperawatan.
4.	Menerapkan caring dalam keperawatan.
5.	Menerapkan prinsip keselamatan klien.
6.	Menerapkan prinsip Pengendalian dan Pencegahan Infeksi.
7.	Melakukan kerjasama tim dalam asuhan keperawatan.
8.	Menerapkan prinsip mutu dalam tindakan keperawatan.
9.	Melakukan proses edukasi kesehatan pada klien terkait dengan kebutuhan dasar.
10.	Mengumpulkan data kuantitatif untuk kegiatanpembuatan laporan kasus klien.
11.	Mengumpulkan data riset sebagai anggota timpenelitian.
12.	Menunjukkan sikap memperlakukan klientanpa membedakan suku,agama, ras danantar golongan.
13.	Menunjukkan sikap pengharapan dan keyakinan terhadap pasien.
14.	Menunjukkan hubungan saling percaya dengan klien dan keluarga.
15.	Menunjukkan sikap asertif.
16.	Menunjukkan sikap empati.
17.	Menunjukkan sikap etik.
18.	Menunjukkan kepatuhan terhadap penerapan standar dan pedoman keperawatan.

19.	Menunjukkan tanggung jawab terhadap penerapan asuhan keperawatan sesuai kewenangannya.
20.	Menunjukkan sikap kerja yang efektif dan efisien dalam pengelolaan klien.
21.	Menunjukkan sikap saling percaya dan menghargai antara anggota tim dalam pengelolaan asuhan keperawatan.
22.	Menunjukkan sikap saling percaya dan menghargai antara anggota tim dalam pengelolaan asuhan keperawatan

23.	Dapat melakukan point of care test (tindakan yang dilakukan pada pasien saat tirah baring)
24.	Melakukan pemberian produk darah dengan aman
25.	Melakukan perawatan luka
26.	Memberikan obat dengan aman dan benar
27.	Memberikan obat injeksi
28.	Memberikan obat injeksi sedasi ringan
29.	Melakukan permintaan pemeriksaan penunjang
30.	Melakukan assesmen fungsional
31.	Melakukan oral gygiene
32.	Melakukan bantuan eliminasi BAB/BAK baik di tempat tidur maupun di kamar mandi
33.	Melakukan assesmen nutrisi
34.	Membantu memberikan makan per-oral pasien sadar
35.	Melakukan pemasangan dan pelepasan NGT
36.	Memberikan makan melalui NGT
37.	Melakukan edukasi nutrisi dasar
38.	Melakukan assesmen eliminasi
39.	Melakukan kompres buli-buli
40.	Memonitoring intake dan output
41.	Melakukan pemasangan dan pelepasan kateter
42.	Melakukan perawatan kateter dan bladder training
43.	Melakukan perawatan kolostomi
44.	Melakukan pemasangan dan pelepasan infus
45.	Melakukan perawatan luka infus
46.	Melakukan managemen nyeri dasar
47.	Melakukan edukasi resiko jatuh dan pemasangan restrain
48.	Melakukan pemberian obat topical
49.	Melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan tingkat ketergantungan parsial.
50.	Melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan tingkat ketergantungan total.
51.	Melakukan pemasangan dan pelepasan mayo tube
52.	Memberikan terapi elektrolit pekat
53.	Melakukan tintrasi obat sesuai advis dokter
54.	Mengoperasikan alat-alat medis khusus (Monitor pasie, Shiringepump, Infuspump)

c. Perawat Klinik II

Perawat klinis II adalah jenjang perawat klinis dengan kemampuan melakukan asuhan keperawatan holistik pada klien secara mandiri dan mengelola klien/sekelompok klien secara tim serta memperoleh bimbingan untuk penanganan masalah lanjut/kompleks. Kompetensi perawat klinis II yaitu:

No	Kompetensi
1.	Melakukan asuhan keperawatan dengantahapan dan pendekatanproses keperawatanpada klien dengan tingkat ketergantunganpartial dan total care.
2.	Menerapkan prinsip kepemimpinan dalam melaksanakan asuhan keperawatan.
3.	Menerapkan konsep pengelolaan asuhan keperawatan pada sekelompok klien.
4.	Mengidentifikasi tingkat ketergantungan klien untuk menentukan intervensi keperawatan.

5.	Menetapkan jenis intervensi keperawatan sesuai tingkat ketergantungan klien.
6.	Menerapkan prinsip etik, legal, dan peka budaya dalam pemberian asuhan keperawatan.
7.	Menggunakan komunikasi terapeutik yang sesuai dengan karakteristik dan masalah klien.
8.	Menerapkan caring yang sesuai dengan karakteristik dan masalah klien.
9.	Melakukan kajian insiden keselamatan klien dan manajemen risiko klinis.
10.	Melakukan kajian terhadap kejadian dan risiko infeksi pada klien.
11.	Melakukan kerjasama antar tim.
12.	Menerapkan pengendalian mutu dengan satu metoda tertentu sesuai kebijakan rumah sakit setempat.
13.	Mengimplementasikan pengendalian mutu asuhan keperawatan.
14.	Merumuskan kebutuhan belajar klien dan keluarga secara holistic sesuai dengan masalah kesehatan klien.
15.	Menyusun rancangan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar klien dan keluarga.
16.	Melakukan proses edukasi kesehatan pada klien dan keluarga.
17.	Mengevaluasi ketercapaian edukasi kesehatan dan rencana tindak lanjut.
18.	Melaksanakan preceptorsip pada tenaga perawat di bawah bimbingannya dan praktikan.
19.	Melakukan diskusi refleksi kasus untuk meningkatkan kualitas pemberian asuhankeperawatan.
20.	Menggunakan hasil penelitian dalam pemberian asuhan keperawatan.
21.	Membantu pelaksanaan riset keperawatan deskriptif.
22.	Melakukan survey keperawatan.
23.	Menunjukkan sikap memperlakukan klien tanpa membedakan suku,agama, ras dan antar golongan.
24.	Menunjukkan sikap pengharapan dan keyakinan terhadap pasien.
25.	Menunjukkan hubungan saling percaya dengan klien dan keluarga.
26.	Menunjukkan sikap asertif.
27.	Menunjukkan sikap empati.
28.	Menunjukkan sikap etik.
29.	Menunjukkan kepatuhan terhadap penerapan standar dan pedoman keperawatan.
30.	Menunjukkan tanggung jawab terhadap penerapan asuhan keperawatan sesuai kewenangannya.
31.	Menunjukkan sikap kerja yang efektif dan efisien dalam pengelolaan klien.
32.	Menunjukkan sikap saling percaya dan menghargai antara anggota tim dalam pengelolaan asuhan keperawatan.

- d. Perawat Klinik III
- Perawat Klinik III adalah jenjang perawat klinis dengan kemampuan melakukan asuhan keperawatan komprehensif pada area spesifik dan mengembangkan pelayanan keperawatan berdasarkan bukti ilmiah dan melaksanakan pembelajaran klinis. Kompetensi perawat klinis III yaitu:

No	Kompetensi
1.	Melakukan pemberian asuhan keperawatan pada klien dengan tingkat ketergantungan parsial dan total dengan masalah kompleks di area keperawatan spesifik.
2.	Menerapkan filosofi dasar keperawatan pada area keperawatan spesifik.
3.	Menerapkan penyelesaian dan pengambilan keputusan masalah etik, legal dalam asuhan keperawatan di unit keperawatan.

4.	Menetapkan jenis intervensi keperawatan sesuai tingkat ketergantungan klien pada lingkup area spesifik.
5.	Menerapkan prinsip kepemimpinan dalam melaksanakan asuhan keperawatan.
6.	Menerapkan konsep pengelolaan asuhan keperawatan pada unit ruang rawat.
7.	Menggunakan metode penugasan yang sesuai dalam pengelolaan asuhan keperawatan di unit ruang rawat
8.	Menetapkan masalah mutu asuhan keperawatan berdasarkan kajian standar dan kebijakan mutu.
9.	Melaksanakan analisis akar masalah (RCA) dan membuat grading risiko terhadap masalah klinis.
10.	Mengidentifikasi kebutuhan belajar klien dan keluarga secara holistic sesuai dengan masalah kesehatan klien di area spesifik.
11.	Mengidentifikasi dan memilih sumber-sumber yang tersedia untuk edukasi kesehatan pada area spesifik.
12.	Melakukan tahapan penyelesaian masalah etik, legal dalam asuhan keperawatan.
13.	Menggunakan komunikasi terapeutik yang sesuai dengan karakteristik dan masalah klien dan keluarga pada area spesifik.
14.	Menerapkan caring yang sesuai dengan karakteristik dan masalah klien di area spesifik.
15.	Menerapkan prinsip kerjasama interdisiplin.
16.	Melaksanakan pengendalian mutu asuhan keperawatan di unit.
17.	Menyusun rancangan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar klien dan keluarga pada area spesifik.
18.	Melakukan proses edukasi kesehatan pada klien dan keluarga pada area spesifik.
19.	Mengevaluasi ketercapaian edukasi kesehatan pada area spesifik dan rencana tindak lanjut.
20.	Melaksanakan preceptorship dan mentorship pada area spesifik.
21.	Menginterpretasi hasil penelitian dalam pemberian asuhan keperawatan pada area spesifik.
22.	Menggunakan hasil penelitian dalam pemberian asuhan keperawatan pada area spesifik.
23.	Melakukan riset keperawatan deskriptif analitik dan inferensial.
24.	Menunjukkan sikap memperlakukan klien tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan.
25.	Menunjukkan sikap pengharapan dan keyakinan terhadap pasien.
26.	Menunjukkan hubungan saling percaya dengan klien dan keluarga.
27.	Menunjukkan sikap asertif.
28.	Menunjukkan sikap etik.
29.	Menunjukkan sikap empati.
30.	Menunjukkan kepatuhan terhadap penerapan standar dan pedoman keperawatan.
31.	Menunjukkan tanggung jawab terhadap penerapan asuhan keperawatan sesuai kewenangannya.
32.	Menunjukkan sikap kerja yang efektif dan efisien dalam pengelolaan klien.
33.	Menunjukkan sikap saling percaya dan menghargai antara anggota tim dalam pengelolaan asuhan keperawatan.

e. Perawat Klinik IV

Perawat klinis IV adalah jenjang perawat klinis dengan kemampuan melakukan asuhan keperawatan pada masalah klien yang kompleks di area spesialisasi dengan pendekatan tata kelola klinis secara interdisiplin, multidisiplin, melakukan riset untuk mengembangkan praktek keperawatan serta mengembangkan pembelajaran klinis. Kompetensi perawat klinis IV yaitu:

No	Kompetensi
1.	Melakukan pemberian asuhan keperawatan pada klien dengan tingkat ketergantungan total dengan masalah kompleks di area spesialisasi.
2.	Menetapkan jenis intervensi keperawatan pada lingkup masalah klien yang kompleks di area spesialisasi.
3.	Menerapkan tata kelola klinis dalam pelayanan keperawatan.
4.	Melakukan evaluasi efektifitas metode penugasan yang sesuai dalam pengelolaan asuhan keperawatan di unit.
5.	Merumuskan indikator keberhasilan intervensi keperawatan.
6.	Menetapkan pengelolaan asuhan klien dengan masalah kompleks pada area spesialisasi.
7.	Menetapkan upaya perbaikan mutu.
8.	Melakukan tahapan penyelesaian masalah etik, legal dalam asuhan keperawatan dalam berbagai lingkup pelayanan keperawatan.
9.	Menggunakan komunikasi terapeutik yang sesuai dengan karakteristik klien dengan masalah kompleks di area spesialisasi.
10.	Menerapkan prinsip caring yang sesuai dengan karakteristik dan masalah klien dengan kasus spesialisasi.
11.	Melaksanakan risiko klinis menggunakan pendekatan Health care Failure Mode & Effect Analysis atau Analisis Efek & Mode Kegagalan di Pelayanan Kesehatan (HFMEA).
12.	Menerapkan prinsip kerjasama secara interdisiplin/interprofesional.
13.	Melakukan upaya perbaikan mutu asuhan keperawatan dengan memberdayakan sumber terkait.
14.	Melakukan pengendalian mutu asuhan keperawatan di beberapa unit.
15.	Menyusun rancangan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar klien dan keluarga pada area spesialisasi.
16.	Melakukan proses edukasi kesehatan pada klien dan keluarga pada area spesialisasi.
17.	Mengevaluasi ketercapaian edukasi kesehatan pada area spesialisasi dan rencana tindak lanjut.
18.	Melaksanakan preceptorship dan mentorship pada area spesialisasi.
19.	Menganalisis hasil penelitian dalam pemberian asuhan keperawatan pada area spesialisasi.
20.	Menggunakan hasil penelitian dalam pemberian asuhan keperawatan pada area spesialisasi.
21.	Menunjukkan sikap memperlakukan klien tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan.
22.	Menunjukkan sikap penghargaan dan keyakinan terhadap pasien.
23.	Menunjukkan hubungan saling percaya dengan klien dan keluarga.
24.	Menunjukkan sikap asertif.
25.	Menunjukkan sikap empati.
26.	Menunjukkan sikap etik.

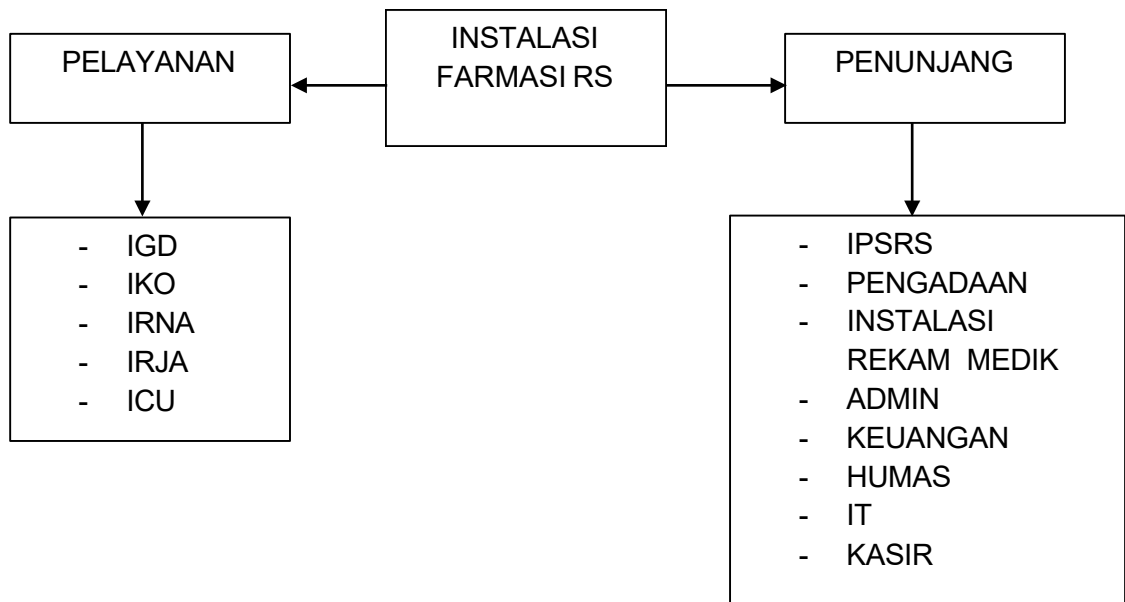
27.	Menunjukkan kepatuhan terhadap penerapan standar dan pedoman keperawatan.
28.	Menunjukkan tanggung jawab terhadap penerapan asuhan keperawatan sesuai kewenangannya.
29.	Menunjukkan sikap kerja yang efektif dan efisien dalam pengelolaan klien.
30.	Menunjukkan sikap saling percaya dan menghargai antara anggotatim dalam pengelolaan asuhan keperawatan.

- f. Perawat Klinik V
- Perawat klinis V adalah jenjang perawat klinisdengan kemampuan memberikan konsultasi klinis keperawatan pada area spesialisik, melakukan tata kelola klinis secara transdisiplin, melakukan risetklinikis untuk pengembangan praktik, profesi dan kependidikan keperawatan. Kompetensi perawatklinikis V yaitu:

No	Kompetensi
1.	Menerapkan prinsip caring yang sesuai dengan karakteristik dan masalah klien yang kompleks di area spesialisik.
2.	Merumuskan strategi penanganan akar masalah dan risiko klinis secara lintas disiplin.
3.	Menganalisis potensi risiko klinis dari intervensi keperawatan.
4.	Menerapkan prinsip dan model kerjasama secara interdisiplin/interprofesional dalam pelayanan kesehatan, transdisiplin.
5.	Menerapkan tata kelola klinis dalam pelayanan kesehatan.
6.	Mengembangkan metode penugasan berdasarkan bukti ilmiah.
7.	Merumuskan indikator kinerja kunci pengelolaan asuhan klien dengan masalah kompleks pada area spesialisik sebagai acuan penilaian.
8.	Mengembangkan metoda perbaikan mutu asuhan keperawatan berdasarkan bukti ilmiah.
9.	Menggunakan filosofi dasar keperawatan sebagai dasar keputusan dalam pemberian asuhan keperawatan spesialisik.
10.	Menyediakan pertimbangan klinis sebagai konsultan dalam asuhan keperawatan klien dengan masalah klien yang kompleks di area spesialisik.
11.	Melakukan pembinaan tata laku dan pertimbangan etik profesi, legal dalam lingkup pelayanan keperawatan.
12.	Menggunakan komunikasi terapeutik yang sesuai dengan karakteristik, masalah klien yang kompleks di area spesialisik sebagai konsultan.
13.	Menyusun strategi penanganan akar masalah dan risiko klinis secara lintas disiplin.
14.	Menggunakan model kerjasama secara interdisiplin/interprofesional pelayanan kesehatan, transdisiplin.
15.	Melakukan pemberian konsultasi klinis dalam asuhan keperawatan pada klien dengan masalah kompleks pada area spesialisik.
16.	Mengembangkan berbagai alternatif intervensi keperawatan berdasarkan bukti ilmiah.
17.	Mengembangkan sistem dalam menjaga mutu asuhan keperawatan secara keberlanjutan.

18.	Melaksanakan konsultasi dan edukasi kesehatan baik bagi peserta didik, sejawat, klien, maupun mitra profesi sesuai kebutuhan.
19.	Menyediakan advokasi sebagai konsultan dalam pelaksanaan preceptorship dan mentorship.
20.	Mengevaluasi hasil penelitian untuk merumuskan intervensi keperawatan.
21.	Melakukan riset keperawatan semi eksperimental dan eksperimental.
22.	Menunjukkan sikap memperlakukan klien tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan.
23.	Menunjukkan sikap pengharapan dan keyakinan terhadap pasien.
24.	Menunjukkan hubungan saling percaya dengan klien dan keluarga.
25.	Menunjukkan sikap asertif.
26.	Menunjukkan sikap empati.
27.	Menunjukkan sikap etik.
28.	Menunjukkan kepatuhan terhadap penerapan standar dan pedoman keperawatan.
29.	Menunjukkan tanggung jawab terhadap penerapan asuhan keperawatan sesuai kewenangannya.
30.	Menunjukkan sikap kerja yang efektif dan efisien dalam pengelolaan klien.
31.	Menunjukkan sikap saling percaya dan menghargai antara anggota tim dalam pengelolaan asuhan keperawatan.

BAB VII
TATA HUBUNGAN KERJA



7.1 POLA HUBUNGAN PELAYANAN

7.1.1 Pola Hubungan dengan Instalasi/Unit Pelayanan Struktural

No.	Unit/Instalasi Terkait	Uraian Hubungan Kerja
1.	Instalasi Gawat Darurat (IGD)	Transport pasien antar bagian
2.	Instalasi Kamar Operasi (IKO)	Transport pasien antar bagian
3.	Instalasi Rawat Inap (IRNA)	Transport pasien antar bagian
4.	Instalasi Rawat Jalan (IRJA)	Transport pasien antar bagian
5.	Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS)	1. Distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. 2. Pelayanan resep pasien rawat inap. 3. Visite pasien rawat inap. 4. Pengecekan <i>box dan trolley emergency</i> . 5. Supervisi harian dan mingguan apoteker di rawat inap. 6. Pengisian rekam medis. 7. Pelayanan farmasi klinik oleh apoteker.

7.1.2 Pola Hubungan dengan Instalasi/Unit Penunjang

No.	Unit/Instalasi Terkait	Uraian Hubungan Kerja
1.	Instalasi Prasarana dan Sarana RS (IPSRS)	1. Perbaikan peralatan dan sarana instalasi ICU. 2. Pengkondisian lingkungan area instalasi ICU.
2.	Unit Pengadaan	Pengadaan sediaan alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
3.	Instalasi Rekam Medik	1. Laporan bulanan dan tahunan di instalasi ICU 2. Kelengkapan pengisian rekam medic.
4.	Bagian Administrasi	1. Keperluan data dan dokumen.

6.	Unit Humas	1. Survei kepuasan Pasien. 2. Standar Pelayanan.
7.	Tim IT	1. Pengecekan komputer dan perangkanya. 2. Perbaikan program Billing SIMRS.
8.	UMUM	1. Kebersihan ruangan. 2. Persiapan ruangan untuk <i>event</i> .
9.	KASIR	1. Pembayaran pelayanan rawat inap.

BAB VIII

POLA KETENAGAAN DAN KUALIFIKASI

Dalam upaya mempersiapkan tenaga medis intensive care unit yang handal perlu kiranya melakukan kegiatan menyediakan dan mempertahankan sumber daya manusia yang tepat. Atas dasar tersebut perlu adanya perencanaan SDM, yaitu proses mengantisipasi dan menyiapkan tenaga dengan kualifikasi sesuai standar. Tujuannya adalah mendayagunakan sumber-sumber tersebut seefektif mungkin sehingga pada waktu yang tepat dapat disediakan sejumlah orang yang sesuai dengan persyaratan jabatan, kualifikasi Pendidikan, sertifikat khusus, pengalaman kerja. Perencanaan bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai sasarannya melalui strategi pengembangan kontribusi acuan yang digunakan menggunakan perhitungan Depkes 2005.

8.1. Tabel Perhitungan Pola Ketenagaan.

a. Tingkat ketergantungan pasien

No	Kategori	Rata jumlah Px/hari	Jumlah jam perawatan/hari	Jumlah jam perawatan/hari
1	Askep Minimal	0	2	0
2	Askep Sedang	0	3,08	0
3	Askep Berat	8	4,15	33,2
4	Askep Maksimal	3	6,16	18,48
	Jumlah	11		51,68

b. Jumlah perawat yang dibutuhkan

$$\frac{\text{Jumlah jam perawatan yang diperlukan/hari} : 51,68}{\text{Jam Kerja efektif/shift} \quad 7} = 7,38$$

c. Koreksi Loss Day

$$\frac{\text{Jumlah Hari Non Efektif (Hari Libur/Cuti/hari Besar) x Jumlah Perawat yang Dibutuhkan}}{\text{Jumlah hari kerja efektif}} \\ \frac{(52+12+14) \times 7,38}{286} \\ \frac{78 \times 7,38}{286} = \frac{575,86}{286} = 2,01$$

d. Tugas Non Keperawatan 25%

$$\frac{\text{Jumlah perawat yang dibutuhkan} + \text{loss day} \times 25}{100} \\ \frac{(7,38+2,01) \times 25}{100} = \frac{234,83}{100} = 2,34$$

e. Jumlah tenaga yang dibutuhkan

$$7,38 + 2,01 + 2,34 = 11,73 = 12 \text{ Orang}$$

Jumlah tenaga di ICU saat ini berjumlah 10 orang

8.2. Tabel Kualifikasi Personil

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Sertifikat Khusus (Diklat yang mendukung)	Pengalaman Kerja
1.	Kepala Instalasi ICU	Dokter Spesialis Anastesi	- Spesialis anesthesiologi dan pelatihan ACLS, BLS	Dokter spesialis anesthesi fungsional di Rumah Sakit lebih dari tiga tahun
2.	Kepala Ruang ICU	S1 Keperawatan	- Surat Sumpah Profesi - STR - SIK - Pelatihan ICU Dasar	Minimal 3 tahun dibidangnya
3.	Kepala Jaga Shift	S1 Keperawatan D3 Keperawatan	- Surat Sumpah Profesi - STR - SIK - Pelatihan ICU Pemula	Minimal 2 tahun dibidangnya
4.	Perawat Pelaksana	D3 Keperawatan	- Surat Sumpah Profesi - STR - SIK - Pelatihan ICU Pemula	Minimal 1 tahun dibidangnya

Adapun distribusi ketenagaan sumber daya manusia di *intensive care unit* Rumah Sakit Prima Husada adalah sebagai berikut :

JABATAN	JUMLAH SDM			KUALIFIKASI						KET
				PENDIDIKAN			SERTIFIKASI			
	STANDAR	KONDISI SAAT INI	KEBUTUHAN	STANDAR	KONDISI SAAT INI	KEBUTUHAN	STANDAR	KONDISI SAAT INI	KEBUTUHAN	
Ka Instalasi	1	1	0	Dokter	+	-	Mutu dan keselamatan pasien	-	+	
							ACLS	+	+	
							PPI	+	-	1 kali/tahun
							Penanggulangan bencana	+	+	1 kali/tahun
							Code blue	+	+	1 kali/tahun
							Komunikasi efektif	-	+	
Ka Ruang	1	1	0	Ners	+	-	Mutu dan keselamatan pasien	+	+	
							PPI	+	+	1 kali/tahun
							Penanggulangan bencana	+	+	1 kali/tahun
							Code blue	+	+	1 kali/tahun
							Komunikasi efektif	+	+	

Pelaksana PK 3	3	3	0	Ners D3	+	-	Mutu dan keselamatan pasien	+	+	
							PPI	+	+	1 kali/tahun
							Penanggulangan bencana	+	+	1 kali/tahun
							Code blue	+	+	1 kali/tahun
							Komunikasi efektif	+	+	
Pelaksana PK 2	10	7	3	Ners D3	+	-	Mutu dan keselamatan pasien	+	+	
							PPI	+	+	1 kali/tahun
							Penanggulangan bencana	+	+	1 kali/tahun
							Code blue	+	+	1 kali/tahun
							Komunikasi efektif	+	+	
Pelaksana PK 1	0	0	0	Ners D3	+	-	Mutu dan keselamatan pasien	-	-	
							PPI	-	-	1 kali/tahun
							Penanggulangan bencana	-	-	1 kali/tahun
							Code blue	-	-	1 kali/tahun
							Komunikasi efektif	-	-	

NAMA JABATAN	WAKTU KERJA	JUMLAH SDM
Kepala ICU	1 shift	1 orang
Kepala ruang ICU	1 shift	1 orang
Penanggung jawab shift	1 shift	1 orang
Perawat Pelaksana	1 shift	5 orang
Tenaga non medis	1 shift	3 orang

Pengaturan Jaga di *Intensive care unit* Rumah Sakit Prima Husada adalah sebagai berikut:

NAMA JABATAN	WAKTU KERJA	DEFINISI WAKTU KERJA	JUMLAH SDM
Kepala Instalasi ICU	1 shift	08.00-16.00	1 orang
Kepala Unit ICU	1 shift	06.30-15.00	1 orang
Penanggung jawab shift	3 shift	06.30-14.30 14.00-21.30 21.00-07.00	3 orang
Perawat Pelaksana	3 shift	06.30-14.30 14.00-21.30 21.00-07.00	3 orang
Tenaga non medis	3 shift	06.30-14.30 14.00-21.30 21.00-07.00	3 orang

Seleksi Calon Karyawan

Seleksi calon karyawan adalah aktivitas atau usaha yang dilakukan untuk mengundang para pelamar sebanyak mungkin sehingga Instalasi *Intensive Care Unit* memiliki kesempatan yang luas untuk menemukan calon yang paling sesuai dengan tuntutan jabatan yang diinginkan. Seleksi calon karyawan dilakukan karena berdasarkan analisa kebutuhan tenaga, ditemukan jumlah pasien dan kegiatan tidak seimbang dengan jumlah tenaga yang ada.

Berdasarkan sumber seleksi calon karyawan dapat dibagi dua yaitu:

1. Dari dalam Rumah Sakit Prima Husada sendiri (*internal resources*)
Menarik calon dari dalam RS Prima Husada sendiri (*Internal resources*) memiliki keuntungan lebih yaitu calon sudah dikenal dengan kinerja yang baik dan proses dapat dilakukan dengan lebih cepat dibanding menarik calon dari luar RS Prima Husada. Untuk mendapatkan calon pelamar dapat melalui berkas-berkas pelamar yang masuk ke rumah sakit Prima Husada
2. Dari luar RS. Prima Husada (*external resources*)
Proses penarikan calon dari luar RS. Prima Husada ini dapat dilakukan dengan cara iklan media cetak dan kerja sama dengan lembaga pendidikan tentang kebutuhan dengan kualifikasi tertentu.

Kriteria calon karyawan menurut standar Instalasi ICU RS Prima Husada :

1. Perawat
 - a. Lulusan D3 dan SI Keperawatan
 - b. Berasal dari Perguruan Tinggi dengan minimal akreditasi B.
 - c. Memiliki IPK minimal 3,00.
 - d. Sehat jasmani dan rohani.
 - e. Memiliki pemahaman tentang Pelayanan RS dengan baik.
 - f. Mudah bekerja secara mandiri dan tim.
 - g. Memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun
 - h. Memiliki sertifikat Pelatihan ICU Pemula atau Dasar

8.3. Pengembangan SDM

Untuk meningkatkan mutu pelayanan di *Intensive Care Unit* khususnya dan Rumah Sakit Prima Husada umumnya, diperlukan pembinaan/pengembangan kompetensi tenaga perawat ICU. Pembinaan/ pengembangan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pelaksanaan tugas dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja dan menambah pengetahuan wawasan bidang pelayanan keperawatan.

Pengembangan sumber daya manusia dapat di lakukan dengan dua cara yakni:

1. Pendidikan

Tenaga dengan pendidikan setingkat SMA diberi ijin untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan DIII, begitu juga tenaga dengan pendidikan setingkat DIII diberi ijin untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan Sarjana

2. Pelatihan

Pelatihan untuk peningkatan kompetensi perawat ICU di Instalasi intensive care unit dilaksanakan melalui :

- a. *Internal Training* yaitu program pelatihan yang diselenggarakan oleh RS Prima Husada, yang sudah dilaksanakan yaitu pelatihan PPI dasar dan standar keselamatan pasien, komunikasi efektif, pelatihan apar dan BHD
- c. *External Training* yaitu program pelatihan diluar rumah sakit yang diikuti sesuai dengan kebutuhan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit khususnya mutu pelayanan Instalasi ICU.

BAB IX
KEGIATAN ORIENTASI

9.1 Orientasi tenaga medis :

HARI KE	MATERI	WAKTU	METODE	PENANGGUNG JAWAB
1	Penjelasan status kepegawaian Penjelasan program orientasi yang akan diterima pegawai, peraturan dan tata tertib masa orientasi Kepada pegawai dikenalkan seluruh unit kerja di Rumah Sakit Prima Husada Orientasi di unit kerja dimana pegawai ditempatkan Pegawai diberikan berbagai materi orientasi dengan penjadwalan khusus meliputi : 1. Visi, misi, nilai, struktur organisasi 2. Perjanjian kerja 3. Etika bekerja 4. Kesejahteraan spiritual 5. Service excellence 6. Handling complaints 7. Produk produk rumah sakit 8. <i>Basic life support</i> 9. Penanggulangan bencana kebakaran 10. Patient safety 11. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	7 jam	Ceramah dan diskusi	SDM
2	Mempelajari SPO Keperawatan. Mempelajari Pedoman Pelayanan dan Pedoman Organisasi Instalasi ICU	2 jam	Ceramah, membaca , dan diskusi	Kepala Instalasi ICU Kepala unit ICU
3	Mempelajari dan praktek alur pelayanan pasien rawat inap ICU. Mempelajari tata cara penentuan dan penerimaan kriteria masuk dan keluar ICU Mempelajari tata cara penerimaan	5 jam	Ceramah, diskusi, dan praktek	Kepala Instalasi ICU Kepala unit ICU

4	Mempelajari dan praktek alur pelayanan pasien rawat inap yang membutuhkan instalasi ICU. Pengisian RM pasien. Visite dokter. Mempelajari <i>items</i> pada SIM-RS instalasi rawat inap.	7 jam	Ceramah, diskusi, dan praktek	Kepala unit ICU
---	--	-------	--	-----------------

BAB X PERTEMUAN RAPAT

Rapat merupakan suatu pertemuan yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk membicarakan atau memecahkan suatu masalah tertentu. Tujuannya sebagai berikut :

1. Dapat membantu terselenggaranya pelayanan keperawatan yang profesional di Instalasi ICU Rumah Sakit Prima Husada.
2. Dapat menggali segala permasalahan terkait dengan pemberian pelayanan di Instalasi ICU.
3. Dapat mencari jalan keluar atau pemecahan permasalahan yang terkait dengan pelayanan di Instalasi ICU.

Rapat terdiri dari 2 macam yaitu :

Rapat Rutin

1. Rapat koordinasi antar unit diselenggarakan pada setiap Rabu jam 13.30 s/d selesai di Hall Akasia. Rapat ini dihadiri oleh kepala instalasi, kepala ruangan, dan unit-unit terkait untuk membahas tentang koordinasi antar unit dalam satu RS.
2. *Daily report* dilakukan setiap hari jam 13.00-14.00 yang bertempat di Hall Akasia. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing unit untuk membahas permasalahan di masing-masing unit serta update informasi terbaru mengenai RS Prima Husada.
3. Rapat internal Instalasi ICU dilakukan pada minggu pertama 1 bulan sekali. Rapat ini dihadiri oleh seluruh tim Instalasi ICU RSPH untuk membahas permasalahan internal ataupun eksternal, koordinasi internal, *update* keilmuan, dan lain-lain.

Rapat Insidentil

1. Rapat Insidentil diselenggarakan sewaktu-waktu bila ada masalah atau sesuatu hal yang perlu dibahas dan sosialisasi kebijakan baru.

BAB XI
PELAPORAN

Berikut data laporan instalasi ICU meliputi :

No	Jenis Laporan	Nama Laporan	Uraian Laporan
1.	Laporan Harian	Laporan sensus harian	Laporan sensus harian meliputi tanggal laporan, shift yang bertugas, jumlah kesalahan, prosentase kesalahan, petugas tenaga medis yang melakukan kesalahan. Kepala ruangan yang bertanggung jawab mengolah data tersebut dan melaporkan pada unit SDM setiap tiga bulan.
		Laporan rapor dokter	Laporan rapor dokter meliputi tanggal laporan, ketidaksiapan assessment awal medis (DPJP) pasien rawat inap 1x24 jam kejadian tidak dilsaksanakan assessment pra anastesi oleh dokter anastesi. Kepala ruangan yang bertanggung jawab mengolah data tersebut dan melaporkan pada unit SDM setiap tiga bulan.
2.	Laporan Bulanan	Laporan jadwal dinas tenaga medis	Laporan jadwal dinas ICU disusun oleh kepala unit ICU yang disetujui oleh kepala instalasi ICU dan asisten manager penunjang medic
		Laporan bulanan unit	Laporan bulanan unit disusun oleh kepala unit ICU yang melaporkan kebutuhan jumlah SDM, fasilitas, pengembangan pelayanan, kinerja produktivitas, mutu, evaluasi jadwal kegiatan, serta kritik dan saran dalam rangka perbaikan instalasi ICU.
3.	Laporan Tahunan/ semester	Laporan evaluasi kinerja individu	Laporan evaluasi kinerja individu dilakukan oleh kepala unit ICU untuk mengevaluasi kinerja perawat pelaksana. Evaluasi kinerja juga dilakukan pada tenaga perawat pelaksana yang dilakukan oleh kepala unit ICU. Hal ini bertujuan untuk memantau perkembangan kinerja karyawan dan melakukan perbaikan apabila terdapat yang kurang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 08 September 2025
PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes